

Sérvices sexuels sur un adulte par une personne n'étant ni l'époux(se) ni le (la) partenaire, confirmés (p. 941)

995.83 (T74.21XA) Rencontre initiale

995.83 (T74.21XD) Rencontre ultérieure

Sérvices sexuels sur un adulte par une personne n'étant ni l'époux(se) ni le (la) partenaire, suspectés (p. 942)

995.83 (T76.21XA) Rencontre initiale

995.83 (T76.21XD) Rencontre ultérieure

Sérvices psychologiques sur un adulte par une personne n'étant ni l'époux(se) ni le (la) partenaire, confirmés (p. 942)

995.82 (T74.31XA) Rencontre initiale

995.82 (T74.31XD) Rencontre ultérieure

Sérvices psychologiques sur un adulte par une personne n'étant ni l'époux(se) ni le (la) partenaire, suspectés (p. 942)

995.82 (T76.31XA) Rencontre initiale

995.82 (T76.31XD) Rencontre ultérieure

Autres circonstances liées aux sérvices sur un adulte par une personne n'étant ni l'époux(se) ni le (la) partenaire (p. 942)

V65.49 (Z69.81) Rencontre pour des soins de santé mentale pour la victime adulte de sérvices par une personne n'étant ni l'époux(se) ni le (la) partenaire

V62.83 (Z69.82) Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur de sérvices sur un adulte n'étant ni l'époux(se) ni le (la) partenaire

Problèmes éducatifs et professionnels (p. 942)

Problèmes éducatifs (p. 942)

V62.3 (Z55.9) Problème scolaire ou éducatif (p. 942)

Problèmes professionnels (p. 942)

V62.21 (Z56.82) Problème lié à un déploiement militaire (p. 942)

V62.29 (Z56.9) Autre problème lié à la profession (p. 943)

Problèmes de logement et problèmes économiques (p. 943)

Problèmes de logement (p. 943)

V60.0 (Z59.0) Sans-abri (p. 943)

- V60.1 (Z59.1)** Logement inadéquat (p. 943)
- V60.89 (Z59.2)** Conflits de voisinage (avec les voisins, les locataires ou le propriétaire) (p. 943)
- V60.6 (Z59.3)** Problème lié à la vie en institution (p. 943)

Problèmes économiques (p. 943)

- V60.2 (Z59.4)** Absence de nourriture adéquate ou d'eau potable (p. 943)
- V60.2 (Z59.5)** Pauvreté extrême (p. 943)
- V60.2 (Z59.6)** Bas revenus (p. 943)
- V60.2 (Z59.7)** Insuffisance de couverture ou de protection sociale (p. 944)
- V60.9 (Z59.9)** Problème de logement ou économique non spécifié (p. 944)

Autres problèmes liés à l'environnement social (p. 944)

- V62.89 (Z60.0)** Problème en rapport avec une étape de la vie (p. 944)
- V60.3 (Z60.2)** Problème lié au fait de vivre seul (p. 944)
- V62.4 (Z60.3)** Difficultés d'acculturation (p. 944)
- V62.4 (Z60.4)** Exclusion ou rejet social (p. 944)
- V62.4 (Z60.5)** Cible d'une discrimination nuisible ou d'une persécution (perçues) (p. 944)
- V62.9 (Z60.9)** Problème lié à l'environnement social non spécifié (p. 945)

Problèmes liés à la criminalité ou aux interactions avec la justice (p. 945)

- V62.89 (Z65.4)** Victime de crime (p. 945)
- V62.5 (Z65.0)** Condamnation en procédure civile ou pénale sans emprisonnement (p. 945)
- V62.5 (Z65.1)** Emprisonnement ou autre incarcération (p. 945)
- V62.5 (Z65.2)** Problèmes liés à la libération de prison (p. 945)
- V62.5 (Z65.3)** Problèmes liés à d'autres circonstances juridiques (p. 945)

Autres contacts avec les services de santé pour des conseils et des avis médicaux (p. 945)

- V65.49 (Z70.9)** Consultation relative à la sexualité (p. 945)
- V65.40 (Z71.9)** Autre demande de conseils ou de consultation (p. 945)

Problèmes liés à d'autres circonstances psychosociales, personnelles et environnementales (p. 945)

- V62.89 (Z65.8)** Problème religieux ou spirituel (p. 945)
- V61.7 (Z64.0)** Problèmes liés à une grossesse non désirée (p. 945)
- V61.5 (Z64.1)** Problèmes liés à la multiparité (p. 945)
- V62.89 (Z64.4)** Désaccord avec un prestataire de services sociaux, y compris un officier de probation, un gestionnaire de cas (coordonnateur de soins) ou un travailleur social (p. 945)
- V62.89 (Z65.4)** Victime de terrorisme ou de torture (p. 946)
- V62.22 (Z65.5)** Exposition à une catastrophe, à la guerre ou à d'autres hostilités (p. 946)
- V62.89 (Z65.8)** Autres problèmes liés à des circonstances psychosociales (p. 946)
- V62.9 (Z65.9)** Problème non spécifié lié à des circonstances psychosociales non spécifiées (p. 946)

Autres circonstances de l'histoire personnelle (p. 946)

- V15.49 (Z91.49)** Autres antécédents personnels de traumatisme psychologique (p. 946)
- V15.59 (Z91.5)** Antécédents personnels d'automutilation (p. 946)
- V62.22 (Z91.82)** Antécédents personnels de déploiement militaire (p. 946)
- V15.89 (Z91.89)** Autres facteurs de risque personnels (p. 946)
- V69.9 (Z72.9)** Problème lié au style de vie (p. 946)
- V71.01 (Z72.811)** Comportement antisocial de l'adulte (p. 946)
- V71.02 (Z72.810)** Comportement antisocial de l'enfant ou de l'adolescent (p. 946)

Problèmes liés à l'accès aux soins médicaux et aux autres types de soins (p. 946)

- V63.9 (Z75.3)** Indisponibilité ou inaccessibilité des services de santé (p. 946)
- V63.8 (Z75.4)** Indisponibilité ou inaccessibilité des autres services d'aide (p. 946)

Non-observance du traitement médical (p. 946)

- V15.81 (Z91.19)** Non-observance du traitement médical (p. 946)
- 278.00 (E66.9)** Surpoids ou obésité (p. 947)
- V65.2 (Z76.5)** Simulation (p. 947)
- V40.31 (Z91.83)** Déambulation associée à un trouble mental (p. 947)
- V62.89 (R41.83)** Fonctionnement intellectuel limite (p. 948)

Préface

Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) publié par l'Association américaine de psychiatrie (APA) est une classification des troubles mentaux assortis de leurs critères, destiné à faciliter l'élaboration de diagnostics plus fiables. Au cours de ses éditions successives dans les 60 dernières années, il est devenu une référence pour la pratique clinique dans le domaine de la santé mentale. La description exhaustive des processus pathologiques sous-jacents n'étant pas possible pour la plupart des troubles mentaux, il est important de souligner que les critères diagnostiques actuels sont la meilleure description disponible de la manière dont les troubles mentaux s'expriment et peuvent être identifiés par des cliniciens dûment formés. Le DSM est destiné à servir de guide pratique, fonctionnel et adaptable pour organiser l'information pouvant aider au diagnostic et au traitement adéquat des troubles mentaux. C'est un outil pour les cliniciens, une ressource éducative essentielle pour les étudiants et les praticiens, et une référence pour les chercheurs dans le domaine de la santé mentale.

Bien que cette édition du DSM ait été conçue avant tout pour être un guide utile dans la pratique clinique, elle doit être applicable, en tant que nomenclature officielle, à une grande diversité de contextes. Le DSM est utilisé par des cliniciens et des chercheurs de différentes orientations (biologique, psychodynamique, cognitive, comportementaliste, interpersonnelle, familiale/systémique) qui s'efforcent tous d'adopter un langage commun pour communiquer sur les caractéristiques essentielles des troubles mentaux présentés par leurs patients. L'information est utile à tous les professionnels associés aux divers aspects des soins dans la santé mentale incluant les psychiatres, les médecins d'autres spécialités, les psychologues, les travailleurs sociaux, les infirmier(ère)s, les spécialistes en médecine légale et juridique, les ergothérapeutes et thérapeutes en centres de réadaptation, et d'autres professionnels de la santé. Les critères sont concis et explicites, et destinés à faciliter une évaluation objective des symptômes dans des situations cliniques variées, que ce soit en hospitalisation, en hospitalisation partielle, en consultation ambulatoire, en psychiatrie de liaison, en pratique privée, dans les soins de première intention ou dans les études épidémiologiques des troubles mentaux en population générale. Le DSM-5 est également un outil de collecte et de diffusion de statistiques précises en santé publique sur la morbidité et la mortalité des troubles mentaux. Enfin, les critères diagnostiques et le texte explicatif sont utilisés comme manuel de référence pour les étudiants au début de leur pratique, lorsqu'ils ont besoin d'une méthode structurée pour comprendre et diagnostiquer les troubles mentaux. Le DSM sert également de manuel de référence pour les professionnels chevronnés qui rencontrent des maladies rares pour la première fois. Heureusement, toutes ces utilisations sont compatibles entre elles.

Ces différents besoins et contraintes ont été pris en considération dans l'élaboration du DSM-5. La classification des troubles est harmonisée avec la Classification internationale des maladies (CIM) de l'Organisation mondiale de la santé, qui est le système de codage officiel utilisé aux États-Unis, de sorte que les critères du DSM définissent les troubles identifiés par leur intitulé diagnostique et leur code dans la CIM. Dans le DSM-5, les deux codes de la CIM-9-MC et la CIM-10-MC (dont l'adoption était prévue en octobre 2014) sont indiqués et reliés aux troubles pertinents dans la classification.

Bien que le DSM-5 soit une classification catégorielle de troubles distincts, les pathologies mentales ne rentrent jamais complètement dans le cadre d'entités diagnostiques uniques. Certains domaines de symptômes, tels que la dépression et l'anxiété, impliquent de multiples catégories diagnostiques et peuvent refléter des vulnérabilités sous-jacentes communes à un groupe plus large de troubles. Compte tenu de cette réalité, les troubles répertoriés dans le DSM-5 ont été réordonnés en une structure organisationnelle modifiée destinée à stimuler de nouvelles perspectives cliniques. Cette nouvelle structure correspond à la structure organisationnelle des troubles prévue dans la CIM-11, dont la parution est prévue en 2015. D'autres améliorations ont été introduites pour faciliter son utilisation dans tous les contextes suivants.

- **Présentation des questions développementales liées au diagnostic.** Les modifications apportées à l'organisation des chapitres reflètent mieux une approche considérant l'évolution au cours de la vie, les troubles les plus fréquemment diagnostiqués dans l'enfance (p. ex. les troubles neurodéveloppementaux) figurant au début du manuel, et les troubles le plus souvent observables chez l'adulte âgé (p. ex. les troubles neurocognitifs) à la fin du manuel. En outre, les paragraphes sur le développement et l'évolution décrivent les modifications possibles du tableau clinique au cours de la vie. Les facteurs liés à l'âge intervenant dans le diagnostic (p. ex. la manifestation des symptômes et les différences de prévalence dans certains groupes d'âge) sont également inclus dans le texte. Pour insister sur ce point, ces facteurs liés à l'âge ont été ajoutés aux critères eux-mêmes quand cela est applicable (p. ex. dans l'ensemble des critères définissant l'insomnie et le stress post-traumatique, des critères spécifiques décrivent comment les symptômes peuvent s'exprimer chez les enfants). De même, les questions liées au genre et à la culture ont été intégrées dans les troubles quand cela est applicable.
- **Intégration des résultats scientifiques des recherches les plus récentes en génétique et en neuro-imagerie.** L'évolution de la structure des chapitres a tenu compte des recherches récentes en neurosciences et des études d'association génétique entre les groupes diagnostiques. Des facteurs de risque génétiques et physiologiques, des indicateurs pronostiques et certains marqueurs diagnostiques présumés sont mis en évidence dans le texte. Cette nouvelle structure des chapitres devrait permettre d'améliorer la capacité des cliniciens à identifier les diagnostics qui sont réunis dans un spectre de troubles en se fondant sur leurs caractères communs en termes de circuits cérébraux, de vulnérabilité génétique et de facteurs environnementaux.
- **Regroupement du trouble autistique, du syndrome d'Asperger et du trouble envahissant du développement dans le trouble du spectre de l'autisme.** Ces troubles ne sont pas distincts et leurs symptômes font partie d'un seul continuum allant de déficits d'intensité légère à grave dans les deux domaines que sont la communication sociale et les comportements/intérêts restreints et répétitifs. Cette modification vise à améliorer la sensibilité et la spécificité des critères diagnostiques du trouble du spectre de l'autisme et à identifier des cibles thérapeutiques plus précises pour les altérations spécifiques considérées.
- **Classification simplifiée des troubles bipolaires et dépressifs.** Les troubles bipolaires et dépressifs sont les affections les plus fréquemment diagnostiquées en psychiatrie. Il était donc important de simplifier la présentation de ces diagnostics pour améliorer à la fois leur utilisation clinique et leur enseignement. Au lieu de séparer la définition des épisodes maniaques, hypomaniaques et dépressifs caractérisés de la définition du trouble bipolaire I, du trouble bipolaire II et du trouble dépressif caractérisé comme dans l'édition précédente, nous avons inclus tous les critères constitutifs au sein des critères respectifs de chaque trouble. Cette approche

facilitera le diagnostic au contact du patient et le traitement de ces troubles. De même, les notes explicatives pour différencier le deuil du trouble dépressif caractérisé vont fournir une meilleure orientation clinique que ne le faisait précédemment le simple critère d'exclusion du deuil. Les nouvelles spécifications de détresse anxieuse et de caractéristiques mixtes sont maintenant clairement décrites dans le texte détaillant les diverses spécifications qui accompagnent les critères de ces troubles.

- **Restructuration des troubles de l'usage d'une substance pour plus de cohérence et de clarté.** Les catégories « abus de substance » et « dépendance d'une substance » ont été éliminées et remplacées par une nouvelle catégorie générale de troubles de l'usage d'une substance, la substance spécifique utilisée définissant les troubles spécifiques. Le terme « dépendance » était facilement confondu avec le terme « addiction » alors que la tolérance et le sevrage qui définissaient précédemment la dépendance sont en fait des réponses très normales à des médicaments prescrits affectant le système nerveux central et qu'elles n'indiquent pas nécessairement la présence d'une dépendance. En révisant et clarifiant ces critères dans le DSM-5, nous espérons dissiper le malentendu fréquent concernant ces questions.
- **Spécificité accrue pour les troubles neurocognitifs majeurs et légers.** Compte tenu de l'essor des neurosciences, de la neuropsychologie et de l'imagerie cérébrale au cours des 20 dernières années, il était essentiel de transmettre l'état actuel des connaissances dans le diagnostic de certains types spécifiques de troubles qui étaient désignés précédemment comme des « démences » ou des pathologies cérébrales organiques. Des marqueurs biologiques identifiés par l'imagerie des troubles cérébraux vasculaires et traumatiques, des résultats génétiques moléculaires spécifiques concernant des variantes rares de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Huntington ont fait considérablement progresser les diagnostics cliniques, et ces troubles comme d'autres ont été divisés en sous-types spécifiques.
- **Transition dans la conceptualisation des troubles de la personnalité.** Bien que les avantages d'une approche plus dimensionnelle des troubles de la personnalité aient été identifiés dans les éditions précédentes, la transition d'un système diagnostique catégoriel reposant sur des troubles distincts à un système fondé sur la répartition relative des traits de personnalité n'a pas été largement acceptée. Dans le DSM-5, les troubles catégoriels de la personnalité sont quasiment inchangés par rapport à l'édition précédente. Cependant, un modèle alternatif « hybride » a été proposé dans la section III pour guider la recherche future qui distingue l'évaluation du fonctionnement interpersonnel et l'expression des traits pathologiques de personnalité pour six troubles spécifiques. Un profil plus dimensionnel de l'expression des traits de la personnalité est également proposé pour une approche diagnostique spécifiée par des traits de personnalité.
- **Section III : nouveaux troubles et nouvelles caractéristiques.** Une nouvelle section (section III) a été ajoutée pour mettre en évidence les troubles qui nécessitent des études plus approfondies mais ne sont pas suffisamment bien établis pour faire partie de la classification officielle des troubles mentaux pour une utilisation clinique habituelle. Des mesures dimensionnelles de la sévérité symptomatique dans 13 domaines de symptômes ont également été intégrées pour permettre la mesure des niveaux de gravité variable dans tous les groupes de diagnostic. De même, l'instrument d'évaluation du handicap de l'OMS (WHODAS), une méthode standard pour évaluer les différents niveaux d'incapacité dans les troubles mentaux, fondée sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) et applicable dans toutes les spécialités de la médecine, a été introduite pour

remplacer l'échelle d'évaluation globale du fonctionnement (EGF), plus restrictive. Nous espérons, qu'au fur et mesure de leur mise en œuvre, ces mesures offriront, lors des évaluations diagnostiques, une plus grande précision et davantage de souplesse dans la description des tableaux cliniques et de l'incapacité associée.

- **Compléments en ligne.** Le DSM-5 dispose d'informations complémentaires en ligne. Des instruments de mesure supplémentaires sont disponibles en ligne (www.psychiatry.org/dsm5) pour des évaluations transversales et pour évaluer la sévérité de troubles choisis. En outre, l'entretien de formulation culturelle, l'entretien de formulation culturelle dans sa version de l'informant, ainsi que des modules venant compléter la version de base de l'entretien de la formulation culturelle sont également disponibles en ligne à l'adresse www.psychiatry.org/dsm5.

Ces innovations ont été conçues par les principales autorités internationales dans le domaine des troubles mentaux, et elles ont été mises en œuvre après des revues par des experts, des commentaires du public et une évaluation indépendante par des pairs. Les 13 groupes de travail, sous la direction de la *Task Force* du DSM-5, en liaison avec d'autres organismes d'examen et, finalement, le Conseil d'administration (*Board of Trustees*) de l'APA, représentent collectivement l'expertise mondiale dans la spécialité. Cet effort a été soutenu par un nombre important de conseillers et par le personnel de la division de recherche de l'APA. Les noms de toutes les personnes impliquées sont trop nombreux pour être cités ici mais ils sont énumérés en annexe. Nous sommes extrêmement reconnaissants à ceux qui ont consacré d'innombrables heures et une expertise inestimable à cette entreprise destinée à améliorer le diagnostic des troubles mentaux.

Nous tenons tout particulièrement à remercier les présidents, les coordonnateurs et les membres des 13 groupes de travail énumérés en préambule de ce manuel qui, pendant une période soutenue de 6 ans, ont passé un temps considérable dans cet effort volontaire pour améliorer les données scientifiques de la pratique clinique. Susan K. Schultz, M.D., éditrice de textes, a travaillé sans relâche avec Emily A. Kuhl, Ph.D., rédactrice scientifique senior et éditrice de textes de l'équipe du DSM-5, pour coordonner les efforts des groupes de travail en un tout cohérent. William E. Narrow, M.D., M.P.H., a dirigé le groupe de recherche qui a développé la stratégie globale de recherche pour le DSM-5, y compris les enquêtes sur le terrain qui ont considérablement amélioré la collection d'éléments probants pour cette révision. En outre, nous sommes reconnaissants à ceux qui ont consacré un temps considérable à l'examen indépendant des propositions de révision, incluant Kenneth S. Kendler, M.D., et Robert Freedman, M.D., coprésidents du comité de revue scientifique, John S. McIntyre, M.D., et Joel Yager, M.D., coprésidents du comité clinique et de santé publique, et Glenn Martin, M.D., président du processus de révision fait par l'assemblée de l'APA. Des remerciements spéciaux sont dus à Helena C. Kraemer, Ph.D., pour son expertise en statistiques, à Michael B. First, M.D., pour sa précieuse contribution au codage et à la révision des critères, et à Paul S. Appelbaum, M.D., pour ses conseils sur les questions médico-légales. Maria N. Ward, M.Ed., RHIT¹, CCS-P² a également contribué à la vérification de tous les codes de la CIM. Le *Summit Group*, présidé par Dilip V. Jeste, M.D., incluant ces consultants, les présidents de tous les groupes de révision, les présidents de la *Task Force* et les directeurs exécutifs de l'APA, a fait preuve de leadership et de vision en aidant à parvenir à

1. NDT. *Registered Health Information Technician* : technicien certifié qui vérifie et stocke des dossiers de soins sous un format informatisé.
 2. NDT. *Certified Coding Specialist-Physician-based* : professionnel spécialisé dans le codage des informations médicales dans des lieux de soin.

un compromis et à un consensus. Ce niveau d'engagement a contribué à l'équilibre et l'objectivité qui, selon nous, sont des marques de qualité du DSM-5.

Nous souhaitons en particulier souligner le rôle du remarquable personnel de la division de recherche de l'APA – nommé dans la liste des membres de la *Task Force* et des groupes de travail en préambule de ce manuel – qui a travaillé sans relâche pour interagir avec la *Task Force*, les groupes de travail, les conseillers et réviseurs pour résoudre les problèmes, assurer la liaison entre les groupes, diriger et gérer les enquêtes sur le terrain en pratique clinique courante et en milieu universitaire, et enregistrer les décisions dans ce processus important. En particulier, nous apprécions le soutien et les conseils fournis par James H. Scully Jr., M.D., directeur médical et président exécutif de l'APA, tout au long des années de labeur ayant permis l'élaboration de ce projet. Enfin, nous remercions l'équipe de rédaction et de production de l'*American Psychiatric Publishing* – spécifiquement, Rebecca Rinehart, éditrice, John McDuffie, directeur éditorial, Ann Eng, éditrice senior, Greg Kuny, éditeur en chef, et Tammy Cordova, responsable de la conception graphique – pour leurs conseils permettant de rendre ce projet possible puis de le mener à bien. Cet ouvrage est l'aboutissement des efforts de nombreuses personnes talentueuses qui ont consacré leur temps, leur expertise et leur passion et ont rendu la réalisation du DSM-5 possible.

David J. Kupfer, M.D.

Président de la Task Force du DSM-5

Darrel A. Regier, M.D., M.P.H.

Vice-président de la Task Force du DSM-5

19 décembre 2012

Page laissée en blanc intentionnellement.

SECTION I

Les fondements du DSM-5

Introduction	3
Utilisation du manuel	21
Mise en garde pour l'usage médico-légal du DSM-5	29

Cette section a pour but de donner au lecteur des informations simples sur les objectifs, l'architecture, le contenu et l'utilisation du DSM-5. Elle n'a pas pour ambition de relater de façon exhaustive l'évolution du DSM-5 ; elle souhaite plutôt offrir une vue d'ensemble succincte des éléments les plus importants de cet ouvrage. L'introduction décrit le processus de révision qui a été mené au niveau du public, des professionnels et des experts pour évaluer les critères diagnostiques présentés dans la section II. Un résumé est également présenté de l'architecture du DSM-5, de l'harmonisation avec la CIM-11, de la transition vers un système non axial, et d'une nouvelle approche pour la mesure du handicap. La partie « Utilisation du manuel » inclut la « Définition d'un trouble mental », des considérations médico-légales et un bref survol de la démarche diagnostique et de l'utilisation du codage et des procédures d'enregistrement.

Introduction

La 5^e édition du *Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux* (DSM-5) est le fruit d'une entreprise considérable ayant mobilisé des centaines de personnes qui ont collaboré au même projet pendant une période de plus de 12 ans. Un travail important de réflexion et de délibération a été consacré à l'évaluation des critères diagnostiques, à l'organisation de chaque aspect du manuel, ainsi qu'à la création de nouveaux outils qui, nous l'espérons, seront très utiles aux cliniciens. Tous ces efforts ont eu pour but d'améliorer l'utilité clinique de ce guide pour le diagnostic des troubles mentaux qu'est le DSM-5.

Disposer de diagnostics fiables est essentiel pour orienter les recommandations de traitement, mesurer les taux de prévalence dans les programmes de santé mentale, identifier les groupes de patients en recherche clinique ou en recherche fondamentale, ainsi que fournir des données importantes en santé publique, comme les taux de morbidité ou de mortalité. Avec l'évolution de notre compréhension des maladies mentales et de leurs traitements, tous les professionnels, médecins, scientifiques et cliniciens, ont été amenés à se concentrer sur les caractéristiques de troubles spécifiques et sur leurs implications pour le traitement et la recherche.

Si le DSM a permis de faire des progrès considérables dans la fiabilité diagnostique, il est néanmoins admis (aussi bien par l'Association américaine de psychiatrie [APA] que par l'ensemble de la communauté scientifique du champ de la médecine mentale) que la science par le passé n'a pas été assez mature pour fournir des diagnostics parfaitement valides – c.-à-d. des validateurs scientifiques consistants, solides et objectifs pour chaque trouble recensé par le DSM. La science des troubles mentaux n'a pas fini d'évoluer. Ne serait-ce qu'au cours des deux dernières décennies, depuis la publication du DSM-IV, des progrès réels et durables ont été accomplis dans certains domaines, comme dans les neurosciences cognitives, l'imagerie cérébrale, l'épidémiologie ou la génétique. Les membres de la *Task Force* du DSM-5, qui ont piloté cette nouvelle édition, se sont accordés sur le fait que les avancées en recherche exigent que des changements prudents et itératifs soient introduits si l'on souhaite que le DSM puisse maintenir son rang de classification de référence pour les troubles mentaux. Trouver la juste mesure est délicat : les résultats hypothétiques n'ont pas leur place dans une nosologie officielle, mais il est aussi crucial que le DSM évolue en tenant compte des autres initiatives qui existent dans le domaine de la recherche clinique. À cet égard, une direction importante à prendre consiste à reconnaître de façon générale qu'un système catégoriel trop rigide ne parvient pas à rendre compte de l'expérience clinique ou d'observations scientifiques importantes. Des résultats de très nombreuses études de comorbidité et de transmission familiale des maladies, comme les études de jumeaux et les études en génétique moléculaire, ont fourni des arguments de poids qui renforcent un constat que les cliniciens rigoureux avaient fait de longue date : les frontières entre de nombreuses « catégories » de troubles sont plus poreuses au cours de la vie que ce que le DSM-IV affirmait, et de nombreux symptômes servant à décrire un trouble peuvent apparaître, à différents niveaux de sévérité, dans de nombreux autres troubles. Ces résultats signifient que le DSM, comme toute autre classification médicale, doit trouver les moyens d'introduire des approches dimensionnelles pour les troubles mentaux, et notamment des dimensions transversales aux catégories actuelles. Une telle approche devrait améliorer la précision des descriptions des tableaux cliniques mais aussi la validité des diagnostics (c.-à-d. le degré selon lequel les critères diagnostiques reflètent

de manière complète les manifestations d'un trouble psychopathologique sous-jacent). Le DSM-5 a été conçu pour mieux répondre aux besoins des cliniciens, des patients, des familles et des chercheurs en proposant une description claire et concise de chaque trouble mental suivant des critères diagnostiques explicites, à quoi s'ajoutent, quand cela est approprié, des mesures dimensionnelles qui traversent les frontières diagnostiques, ainsi qu'un court résumé des informations concernant le diagnostic, les facteurs de risque, les caractéristiques associées, les avancées de la recherche et les expressions variées du trouble.

L'usage du DSM pour déterminer un diagnostic requiert un entraînement clinique et de l'expérience. Les critères diagnostiques identifient des symptômes, des comportements, des fonctions cognitives, des traits de personnalité, des signes physiques, des combinaisons syndromiques et des critères de durée, qui exigent une expertise clinique pour ne pas être confondus avec les variations de la vie normale ou les réponses passagères à des situations de stress. Pour faciliter l'examen complet de tous les symptômes présentés par le patient, le DSM peut être utile au clinicien en lui servant de guide pour identifier les symptômes les plus prééminents devant être rapportés pour pouvoir diagnostiquer un trouble. Bien que certains troubles mentaux puissent avoir des limites bien définies à partir d'associations de symptômes, les connaissances scientifiques tendent à placer de nombreux troubles mentaux, sinon la plupart, le long d'un spectre qui relie tous les troubles clairement apparentés présentant des symptômes, des facteurs de risque génétiques ou environnementaux communs, et peut-être même un soubassement neuronal commun (c'est sans doute dans le domaine d'un sous-groupe des troubles anxieux, grâce à la neuro-imagerie et aux modèles animaux, que cela a été le mieux établi). En bref, il a fallu reconnaître que les frontières entre les troubles mentaux sont plus perméables qu'on ne le croyait auparavant.

De nombreux professionnels de santé ainsi que des disciplines associées ont été sollicités pour le développement et l'évaluation du DSM-5 : médecins, psychologues, travailleurs sociaux, infirmiers, conseillers, épidémiologistes, statisticiens, neuroscientifiques, neuropsychologues. Mais ont aussi participé au processus de révision du DSM-5, par leurs avis sur les troubles mentaux décrits : des patients, des familles, des juges, des associations de consommateurs et des groupes d'entraide. Leurs analyses attentives des descriptions proposées ainsi que des textes explicatifs ont permis de manière essentielle d'améliorer la compréhension de ces conditions pathologiques, de réduire la stigmatisation qui leur est associée, et de réfléchir aux traitements et aux thérapies possibles.

Bref rappel historique

Le plus ancien prédécesseur du DSM fut publié en 1844 par l'APA. Il s'agissait d'une classification statistique destinée à enregistrer les malades mentaux en institutions. Son but était d'améliorer la communication autour des différents types de patients pris en charge à l'hôpital. Ce précurseur du DSM servit également comme outil pour le recensement complet de la population américaine. Après la Deuxième Guerre mondiale, le DSM se transforma, à travers quatre éditions majeures, en un système de classification diagnostique détaillant les caractéristiques essentielles de l'ensemble des troubles mentaux, destiné aux psychiatres, médecins et autres professionnels de la santé mentale. L'édition actuelle, le DSM-5, poursuit le but fixé par ses prédécesseurs (le plus récent étant le DSM-IV-TR, ou *Text Revision*, publié en 2000) de fournir des grilles indicatives pour les diagnostics qui puissent être utiles au traitement et à la prise de décision.

Processus de révision du DSM-5

En 1999, l'APA procéda à une évaluation des forces et des faiblesses du DSM en s'appuyant sur des recherches nouvelles qui mettaient en cause les frontières établies pour certains troubles mentaux. Cet effort fut coordonné entre la division de la santé mentale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Association mondiale de psychiatrie, et l'Institut national de santé mentale des États-Unis ou *National Institute of Mental Health* (NIMH). Il prit la forme d'une série de conférences dont les actes furent publiés dans une monographie de 2002 intitulée *Research Agenda for DSM-V*. Par la suite, entre 2003 et 2008, un accord de coopération entre l'APA et l'OMS reçut l'appui du NIMH, du *National Institute on Drug Abuse* (NIDA) et du *National Institute on Alcoholism and Alcohol Abuse* (NIAAA) pour organiser 13 conférences internationales de planification des recherches pour le DSM-5, mobilisant près de 400 participants issus de 39 pays. Le but de ces conférences était d'analyser la littérature mondiale dans chaque domaine spécifique du diagnostic et de préparer les révisions à apporter à la fois au DSM-5 et à la 11^e révision de la *Classification internationale des maladies* (CIM-11). Les travaux issus de ces conférences ont formé la base préalable des études prévues au sein de la *Task Force* du DSM-5. Ils ont ainsi préparé le terrain pour cette nouvelle édition du DSM.

En 2006, l'APA nomma David J. Kupfer et Darell A. Regier respectivement président et vice-président de la *Task Force* du DSM-5. Ceux-ci eurent pour mission de proposer les présidents des 13 groupes de travail diagnostique ainsi que les autres membres de la *Task Force* en charge de la supervision du développement du DSM-5, dans des domaines d'expertise pluridisciplinaires. Un processus de contrôle additionnel fut mis en place par le Conseil d'administration (*Board of Trustees*) de l'APA afin de rendre publiques les sources de revenus et de prévenir les conflits d'intérêts chez les membres composant la *Task Force* et les groupes de travail. Cela a permis de fixer un nouveau cadre réglementaire dans le champ psychiatrique : l'ensemble de tous les revenus et de toutes les bourses de recherche provenant de sources commerciales (et notamment de l'industrie pharmaceutique) a dû être déclaré pour les trois dernières années ; un plafond a été fixé pour tous les revenus commerciaux ; enfin, les déclarations d'intérêt ont été rendues publiques sur un site Internet. Par la suite, la *Task Force*, constituée de 28 membres, fut approuvée en 2007. Puis ce fut la nomination de plus de 130 membres au sein des groupes de travail qui fut approuvée en 2008. Par ailleurs, plus de 400 conseillers supplémentaires furent autorisés à participer au processus de révision au sein des groupes de travail (mais sans possibilité de participer aux votes décisionnels). Il était plus qu'important, afin de soutenir les efforts de la *Task Force* et des groupes de travail, de définir clairement les modalités de ce nouveau stade de développement de la classification des troubles mentaux. Cela a été rendu possible grâce au travail de réflexion opéré par la *Task Force* et les groupes de travail sur l'histoire du DSM-IV, ses atouts et ses limites actuelles, ainsi que sur les directions stratégiques à prendre pour sa révision. Un processus intensif, qui allait durer 6 ans, put alors commencer où il fut procédé à des revues de littérature, des analyses secondaires, des publications de rapports de recherche dans des journaux scientifiques, au développement de versions de travail des nouveaux critères diagnostiques, à la publication sur le site du DSM-5 de ces premières versions de travail afin de solliciter les commentaires publics, à la présentation des premiers résultats lors de congrès professionnels, à la réalisation d'enquêtes sur le terrain, à la révision enfin des critères et des textes explicatifs.

Propositions de révision

Toutes les propositions de révision des critères diagnostiques pour le DSM-5 ont été développées par les membres des groupes de travail en tenant compte des critères suivants : la justification du changement envisagé, son ampleur, l'impact qu'il pourrait avoir sur la prise en charge clinique ou sur la santé publique, la robustesse des recherches qui plaident en faveur de ce changement, sa clarté générale et son utilité clinique. Les différents types de révisions possibles étaient : des changements dans les critères diagnostiques, l'ajout de nouveaux troubles, de sous-types de troubles, ou de spécifications, ou encore l'élimination de troubles existants.

La première étape dans les propositions de révision a consisté à identifier les forces et les faiblesses de la nosologie actuelle et de ses critères. Les découvertes scientifiques des deux dernières décennies ont été prises en compte et intégrées dans un plan de recherche qui a servi à identifier les changements envisageables à l'aune des revues de littérature et des analyses de données secondaires. Quatre principes ont guidé les suggestions de révisions : 1) le DSM-5 est d'abord destiné à être un manuel utilisé par les cliniciens, et toute révision doit pouvoir s'intégrer à la pratique clinique ordinaire ; 2) les suggestions de révision devaient être guidées par les preuves apportées par la recherche ; 3) il fallait quand cela était possible maintenir la continuité avec les éditions précédentes du DSM ; 4) aucune contrainte ne devait *a priori* peser sur le degré de changement introduit par rapport au DSM-IV.

À partir des revues de littérature initiales, les groupes de travail ont identifié les enjeux cruciaux dans leurs domaines diagnostiques respectifs. Ils se sont aussi attelés à l'examen de problèmes méthodologiques plus larges, comme la présence de données contradictoires dans la littérature, la recherche d'une définition remodelée du trouble mental, les problèmes de recoupement entre tous les troubles mentaux, et la révision des troubles rangés dans le DSM-IV sous la bannière des troubles « non spécifiés » (*not otherwise specified*). Toute inclusion d'une proposition dans la section II du *Manuel* devait prendre en compte ses avantages et ses défauts sur le plan de la santé publique et de l'utilité clinique, la force de ses preuves, et l'ampleur du changement. Pour ce qui concernait l'ajout de nouveaux diagnostics, de sous-types de troubles ou de spécifications, certaines informations supplémentaires étaient requises, et notamment la preuve de leur fidélité (c.-à-d. le degré avec lequel deux cliniciens peuvent indépendamment parvenir au même diagnostic pour un patient donné). Certains troubles qui présentaient peu d'utilité clinique et une faible validité furent examinés afin de décider s'il convenait ou non de les éliminer. L'inclusion de certaines affections dans la section III du *Manuel*, où sont regroupés les « troubles proposés pour des études supplémentaires », a été décidée en fonction : de la quantité de preuves empiriques disponibles pour le trouble considéré, de sa fiabilité et de sa validité diagnostiques, de l'existence claire d'un besoin clinique, du bénéfice potentiel que l'on pourrait tirer de recherches supplémentaires.

Enquêtes sur le terrain du DSM-5

Le recours à des enquêtes sur le terrain afin de démontrer empiriquement la fidélité des diagnostics fut un progrès remarquable introduit par le DSM-III. Le protocole et la stratégie de mise en œuvre des enquêtes sur le terrain pour le DSM-5 présentent plusieurs changements par rapport aux approches adoptées dans les DSM-III et DSM-IV, en particulier dans la manière d'obtenir des données sur la précision des estimations de fidélité à l'aide des mesures kappa (outil statistique qui mesure le degré d'accord entre cliniciens, corrigé en tenant compte des accords liés au hasard du fait des taux de prévalence) dans le contexte de dispositifs cliniques où l'on observe de très hauts

taux de comorbidité diagnostique. Pour le DSM-5, les enquêtes sur le terrain ont été étendues à deux types distincts de protocoles d'évaluation : un protocole réalisé dans un milieu médical et universitaire large et diversifié, et un autre portant plus spécifiquement sur les pratiques cliniques ordinaires. Le premier type a profité du besoin de disposer de grands échantillons de patients pour tester certaines hypothèses sur la fidélité et l'utilité clinique d'un certain nombre de diagnostics dans des populations diverses ; le second type a apporté des informations utiles sur la manière dont les révisions proposées sont appliquées en pratique clinique ordinaire par différents groupes d'utilisateurs du DSM. Il est prévu que des études ultérieures, en recherche clinique et fondamentale, soient concentrées sur la validité des critères diagnostiques révisés, qui sont de type catégoriel, ainsi que sur les caractéristiques dimensionnelles sous-jacentes à ces troubles (y compris ceux qui sont actuellement étudiés dans le cadre du projet *Research Domain Criteria* du NIMH).

Les enquêtes sur le terrain en milieu médical et universitaire ont été conduites sur 11 sites nord-américains. Elles ont permis de mesurer la fidélité, la faisabilité et l'utilité clinique de certaines révisions, avec une priorité donnée à celles qui présentent le plus de changements par rapport au DSM-IV, ainsi qu'à celles qui peuvent présenter le plus grand impact pour la santé publique. Tous les patients, pour chaque site concerné, étaient d'abord évalués d'après les diagnostics du DSM-IV ou les symptômes précis susceptibles de prédire plusieurs troubles d'un intérêt particulier pour le DSM-5. Des échantillons stratifiés de 4 à 7 troubles spécifiques, plus un stratum comprenant un échantillon représentatif de tous les autres diagnostics, ont été identifiés dans chaque site. Les patients, après avoir donné leur consentement pour participer à l'étude, étaient distribués de manière aléatoire avant de passer un entretien avec un clinicien tenu dans l'ignorance du diagnostic préalablement posé ; puis un deuxième entretien était conduit par un autre clinicien, lui aussi ignorant des diagnostics précédemment posés. Dans un premier temps, les patients étaient invités à remplir un inventaire symptomatologique transversal assisté par ordinateur, concernant plus d'une douzaine de domaines psychologiques. Les inventaires étaient cotés et rassemblés sur un serveur central, et les résultats étaient ensuite communiqués aux cliniciens qui pouvaient alors procéder à un examen clinique classique (sans protocole structuré). On leur demandait d'enregistrer la présence de critères précis sur un inventaire diagnostique du DSM-5 assisté par ordinateur, puis de poser leurs diagnostics, de coter leur sévérité, et enfin d'enregistrer toutes ces données sur un serveur en ligne centralisé. Ce protocole d'études a permis de calculer le degré d'accord sur un diagnostic de deux cliniciens indépendants (en utilisant la statistique intraclass kappa), ainsi que le taux d'accord d'un seul patient ou de deux cliniciens différents sur deux évaluations séparées de symptômes transversaux, de traits de personnalité, de handicap, et de mesures de sévérité des diagnostics (en utilisant pour cela des coefficients de corrélation intraclasses), tout en offrant des informations sur la précision de ces mesures de fidélité. Cela a également permis de mesurer les taux de prévalence des troubles, dans les populations cliniques concernées, en fonction à la fois du DSM-IV et du DSM-5.

Les études de terrain en pratique clinique ordinaire ont impliqué, quant à elles, le recrutement de psychiatres et d'autres cliniciens du champ de la santé mentale. Un ensemble de cliniciens volontaires, composé de psychiatres généralistes ou spécialisés, de psychologues, de travailleurs sociaux exerçant en clinique, de conseillers, de thérapeutes conjugaux et familiaux, d'infirmiers expérimentés dans le champ psychiatrique, a été spécialement recruté. Les études de terrain ont fourni l'opportunité de présenter les diagnostics et les mesures dimensionnelles proposés pour le DSM-5 à une grande variété de cliniciens, et d'évaluer ainsi leur faisabilité et leur utilité clinique.

Examen public et professionnel

En 2010, l'APA a mis en place un site Internet unique dans le but de faciliter les contributions publiques et professionnelles à l'élaboration du DSM-5. Tous les critères diagnostiques provisoires et les changements proposés dans l'organisation de la classification furent postés et ouverts aux commentaires sur le site www.dsm5.org pendant une période de 2 mois. Plus de 8 000 commentaires ont été reçus. Ces commentaires ont été systématiquement étudiés par les experts au sein des 13 groupes de travail. Le cas échéant, les questions posées et les commentaires formulés ont nourri les discussions entre experts sur les révisions préliminaires ou sur l'orientation des enquêtes sur le terrain. Après révision de la première version des critères diagnostiques et de la nouvelle organisation des chapitres de la classification, une deuxième présentation publique sur le site de l'APA fut organisée en 2011. Les groupes de travail tinrent compte à la fois des commentaires postés sur le site Internet et des résultats des enquêtes sur le terrain du DSM-5 pour proposer une troisième et dernière version de travail des critères, qui fut publiquement présentée sur le site Internet en 2012. Ces trois étapes d'évaluation externe ont permis de rassembler *via* le site Internet plus de 13 000 commentaires signés de manière individuelle, qui ont été reçus et étudiés par les groupes de travail, auxquels il convient d'ajouter plusieurs milliers de signataires organisés autour de pétitions favorables ou opposées à certaines révisions. Tout cet ensemble a permis à la *Task Force* de tenir compte de manière attentive des difficultés soulevées par les usagers du DSM, les patients ou les associations de défense des patients, et d'assurer ainsi que l'utilité clinique resterait une grande priorité.

Examen par les experts

Les membres des 13 groupes de travail, représentant leurs domaines respectifs d'expertise, ont collaboré avec des conseillers et des analystes sous la direction générale de la *Task Force* du DSM-5 pour rédiger les critères diagnostiques et le texte qui les accompagnent. Cet effort a été secondé par une équipe de la Division de la recherche de l'APA, et a été développé par la mise en place d'un réseau de rédacteurs-coordonateurs pour chaque groupe de travail. La préparation du texte a été coordonnée par un rédacteur en chef (*text editor*), en étroite collaboration avec les groupes de travail et sous la direction des présidents de la *Task Force*. Un Comité scientifique de supervision (*Scientific Review Committee* – SRC) a été établi dans le but de développer un processus scientifique de comité de lecture critique ou *peer-reviewing* qui soit extérieur à celui des groupes de travail. Le président du SRC, son vice-président ainsi que les six autres membres qui le composent ont été chargés d'évaluer le degré de solidité scientifique des changements proposés par rapport au DSM-IV. Chaque proposition de révision diagnostique a été présentée sous la forme d'un rapport préparé par le groupe de travail où étaient compilées les preuves justifiant ce changement, et incluant un résumé des données à l'appui de ce changement organisé autour d'un certain nombre de validateurs pour les critères diagnostiques proposés : les validateurs dans les antécédents (comme les facteurs d'agrégation familiale), les validateurs concourants (comme les marqueurs biologiques), les validateurs prospectifs (tels que la réponse au traitement ou l'évolution de la maladie). Les propositions ont été évaluées par le SRC qui leur a attribué une note en fonction de la solidité des données scientifiques mobilisées. Les autres justifications de changement, comme celles qui viennent d'un besoin ou d'une expérience clinique, ou encore d'une demande de révision conceptuelle des catégories diagnostiques, n'ont, en règle générale, pas été considérées comme relevant du domaine de compétence du SRC. Les notes des experts, très variables suivant les propositions, étaient renvoyées

avec un bref commentaire destiné au Conseil d'administration (*Board of Trustees*) de l'APA et aux groupes de travail, pour examen et éventuelle réaction.

Un Comité de clinique et de santé publique (*Clinical and Public Health Committee* – CPHC), composé d'un président, d'un vice-président et de six membres, a été établi dans le but d'évaluer certaines considérations additionnelles comme l'utilité clinique, les questions de santé publique ou de clarification logique pour les critères qui ne présentaient pas selon l'avis du SRC le type requis ou un niveau de preuves jugé suffisant pour introduire un changement. Ce processus d'évaluation s'est révélé particulièrement important pour certains troubles du DSM-IV qui présentaient des insuffisances notoires et pour lesquels les traitements proposés n'avaient pas encore été examinés au cours du processus de révision du DSM et n'avaient pas fait l'objet de confirmations par les études de recherche. Ces troubles particuliers ont été évalués par quatre ou cinq experts extérieurs, et les résultats, rendus anonymes, ont ensuite été analysés par les membres du CPHC, lesquels finalement ont adressé leurs recommandations au Conseil d'administration (*Board of Trustees*) de l'APA ainsi qu'aux groupes de travail.

Un certain nombre d'évaluations médico-légales, touchant les troubles fréquemment rencontrés dans les milieux médico-légaux ou ceux qui risquent fortement d'influencer les décisions judiciaires en matière civile ou pénale, ont été réalisées par les membres du *Council on Psychiatry and Law* de l'APA. Dans certains domaines, et en complément de l'expertise produite par le *Council on Psychiatry and Law*, les groupes de travail ont également été conseillés par des experts en médecine légale.

À chacun des groupes de travail incombait la responsabilité, pendant les 6 ans d'un processus intensif, de procéder dans leurs domaines respectifs à une revue exhaustive de la littérature scientifique, en tenant compte de tous les critères diagnostiques, aussi bien anciens, révisés, que nouveaux, et dans le but d'apprécier les avantages et inconvénients de chaque petit changement successif, comme de chaque changement conceptuel majeur destiné à répondre à la réification conceptuelle inévitable de toute approche conceptuelle diagnostique dès lors qu'elle persiste pendant plusieurs décennies. De tels changements pouvaient d'abord consister à regrouper des domaines diagnostiques précédemment séparés à l'intérieur de spectres plus dimensionnels, comme cela a été le cas pour le trouble du spectre de l'autisme, les troubles de l'usage d'une substance, les dysfonctions sexuelles, ainsi que pour les troubles à symptomatologie somatique et les troubles apparentés. D'autres changements pouvaient consister à devoir corriger, pour certains troubles, les défauts devenus sensibles avec le temps dans le choix des critères opérationnels. Ces derniers types de changement ont d'ailleurs posé des difficultés particulières au SRC et au CPHC, dont les missions n'étaient pas d'évaluer la validité des critères diagnostiques du DSM-IV. La *Task Force* du DSM-5, en revanche, qui a pu examiner tous les changements proposés et qui avait la responsabilité, pendant toute la période de révision, d'évaluer le texte décrivant chaque trouble en même temps que les groupes de travail, s'est trouvée dans la position unique de pouvoir rendre un jugement informé sur les mérites scientifiques respectifs de ces révisions. Par ailleurs, la plupart de ces changements majeurs ont été testés au cours des enquêtes sur le terrain (même si des tests complets de tous les changements proposés n'ont pas pu être réalisés, en raison des limites de temps et de moyens).

La *Task Force* proposa finalement au Conseil d'administration (*Board of Trustees*) de l'APA et au Comité sur le DSM-5 de l'Assemblée de l'APA (*APA Assembly's Committee on DSM-5*) un rapport final exposant certaines des caractéristiques cliniques en termes d'utilité et de faisabilité des révisions proposées. L'Assemblée est un corps délibératif qui représente les différentes branches de districts de l'APA et une appartenance plus large composée de psychiatres venant de tous les endroits des États-Unis, assurant

ainsi une diversité géographique, une diversité aussi en termes d'intérêts et de taille du dispositif clinique. Le Comité sur le DSM-5 est un comité composé à partir des divers chefs de file de l'Assemblée.

Parachevant toutes ces étapes du processus d'évaluation, une session exécutive intitulée « Comité du sommet » fut organisée pour consolider les différents avis provenant des présidents des différents comités d'examen, des présidents de la *Task Force*, d'un conseiller en médecine légale et d'un conseiller en statistique, afin de procéder à un examen préliminaire de chaque trouble mental par les comités exécutifs de l'Assemblée et du Conseil d'administration de l'APA. Après quoi, il fut procédé à un examen préliminaire par l'ensemble des membres du Conseil d'administration de l'APA. L'Assemblée vota, en novembre 2012, pour solliciter l'approbation du Conseil d'administration de l'APA pour la publication du DSM-5, ce qui fut fait en décembre 2012. On trouvera en annexe la liste des nombreux experts, évaluateurs et conseillers qui ont contribué à ce processus.

Structure organisationnelle du DSM-5

Le cœur du DSM-5, dans ses visées cliniques ou de recherche, est constitué par les définitions singulières des troubles fournies au moyen de listes de critères diagnostiques opérationnels. Ces critères ont fait l'objet (mais à des degrés divers) d'un examen scientifique, et de nombreux troubles ont été soumis aux enquêtes sur le terrain afin de mesurer leur fidélité interjuges. En revanche, la classification même des troubles (c'est-à-dire la manière dont les troubles sont regroupés, la superstructure du manuel) n'a pas été considérée, de manière générale, comme étant d'une grande importance scientifique, malgré le fait que bien des décisions aient dû être prises quand les troubles, dans le DSM-III, ont été initialement répartis en chapitres.

Le DSM est une classification médicale des troubles, et en tant que telle, il doit être conçu comme un schéma cognitif historiquement déterminé, appliqué sur l'information clinique et scientifique, en vue d'améliorer sa compréhension et son utilité. De manière peu surprenante, alors que les fondations scientifiques qui ont précédé l'élaboration du DSM-III datent de près d'un demi-siècle, des difficultés inhérentes à la structure du DSM (plutôt qu'à la description des troubles individuels) ont commencé à se poser aussi bien aux cliniciens qu'aux scientifiques. Ces difficultés comprennent les forts taux de comorbidité qui sont trouvés à l'intérieur et entre les différents chapitres du DSM, l'usage excessif et le besoin de se rapporter à des situations cliniques « non spécifiées » (NS), ainsi que la difficulté croissante d'accorder les troubles du DSM avec les résultats des études génétiques et des autres découvertes scientifiques.

Tandis que l'APA et l'OMS avaient, chacune de son côté, commencé à planifier leurs révisions respectives du DSM et de la *Classification internationale des maladies* (CIM), les deux organismes ont envisagé les moyens d'améliorer l'utilité clinique (p. ex. en cherchant à expliquer les phénomènes apparents de comorbidité) et de faciliter la recherche scientifique en repensant les structures organisationnelles des deux classifications en un système linéaire désigné par des codes alphanumériques qui ordonnerait les chapitres suivant une certaine structure rationnelle et relationnelle. Il est apparu crucial, autant aux membres de la *Task Force* du DSM-5 qu'à ceux de l'*International Advisory Group* de l'OMS chargé de la révision de la section de la CIM-10 consacrée aux troubles mentaux et comportementaux, que les révisions touchant à l'organisation de la classification puissent permettre d'améliorer l'utilité clinique tout en se cantonnant aux données scientifiques les plus solidement établies. Bien que le besoin d'une réforme fût

pressant, il était important de tenir compte de l'état actuel des connaissances ainsi que des difficultés soulevées pour la communauté clinique ou pour la recherche par des changements trop rapides ou prématurés. Dans cette optique, la révision de l'organisation de la classification a été pensée dans un esprit volontiers conservateur, comme un processus évolutif de réforme diagnostique guidé par l'émergence de nouvelles preuves scientifiques concernant les relations entre les groupes de troubles pathologiques. En réordonnant et en regroupant les troubles existants, la structure révisée, nous l'espérons, stimulera de nouvelles perspectives cliniques et encouragera les chercheurs dans leurs travaux visant à identifier des facteurs psychologiques et physiologiques transversaux qui ne sont rattachés à aucune désignation catégorielle stricte.

L'utilisation des critères du DSM possède l'indéniable vertu de créer un langage commun entre les cliniciens au sujet des diagnostics des troubles pathologiques. Les critères officiels et les troubles qui ont été considérés comme présentant une applicabilité clinique acceptable sont détaillés dans la section II du *Manuel*. Il faut néanmoins préciser que ces critères diagnostiques, de même que leurs relations au sein de la classification, se justifient à partir des recherches actuelles, et sont à ce titre susceptibles de devoir être modifiés à mesure que de nouvelles données scientifiques seront rassemblées à la fois à l'intérieur et entre les domaines des troubles présentés. Les « affections proposées pour des études supplémentaires », décrites dans la section III, sont celles pour lesquelles nous avons conclu que les preuves scientifiques n'étaient pas encore suffisamment solides pour justifier un usage clinique généralisé. Leurs critères diagnostiques sont néanmoins proposés afin de souligner l'évolution et la direction des avancées scientifiques, ainsi que pour stimuler les recherches futures.

Au cours de n'importe quel processus de révision, et particulièrement au cours d'un processus d'une telle complexité, différents points de vue émergent. Un grand effort a été fourni pour considérer tous les points de vue et, quand cela était justifié, pour les concilier. Pour prendre un exemple, les troubles de la personnalité ont finalement été inclus à la fois dans les sections II et III du *Manuel*. La section II fournit les mêmes critères que le DSM-IV-TR mais avec une mise à jour du texte qui les accompagne. La section III, en revanche, propose le modèle de recherche et de conceptualisation du diagnostic des troubles de la personnalité qui a été développé par le groupe de travail du DSM-5 consacré à la personnalité et aux troubles de la personnalité. Avec l'évolution de ce champ, nous espérons que les deux versions seront utiles pour la pratique clinique et pour les initiatives en recherche.

Harmonisation avec la CIM-11

Les groupes chargés de la révision du DSM et de la CIM se sont accordés sur le but général d'harmoniser, autant que possible, les deux systèmes classificatoires, et cela pour les raisons suivantes :

- L'existence de deux grandes classifications des troubles mentaux entrave la collection et l'utilisation des statistiques nationales de santé, l'élaboration des protocoles d'études cliniques destinés à développer de nouveaux traitements, ainsi que l'appréciation de l'applicabilité globale des résultats par les agences de régulation internationales.
- Plus largement, l'existence de deux classifications complique les tentatives de répliquer les résultats scientifiques sur le plan international.
- Même lorsque le but était d'identifier les mêmes populations de patients, les diagnostics du DSM-IV et ceux de la CIM-10 ne s'accordaient pas toujours.

Très tôt au cours des processus de révisions respectifs, il est apparu que le fait de développer une organisation structurelle commune favoriserait l'harmonisation entre

les classifications. De fait, l'utilisation d'un programme de travail commun a encouragé l'intégration des travaux des groupes de travail du DSM et la CIM, et a permis de se focaliser sur les enjeux scientifiques. L'organisation du DSM-5 et la structure linéaire prévue pour la CIM-11 ont été jugées consistantes par les dirigeants du NIMH avec la structure générale posée au départ de leur projet de recherche *Research Domain Criteria* (RDoC).

Bien sûr, étant donné l'état actuel des connaissances scientifiques, il était prévisible que des désaccords de principe apparaîtraient à propos de la classification en psychopathologie comme à propos des critères spécifiques pour certains troubles. Toutefois, il semble que les divergences les plus notoires entre le DSM et la CIM ne sont pas de nature scientifique mais tiennent plutôt à des artefacts qui découlent historiquement du travail de comités indépendants.

À la surprise des participants ayant contribué aux deux processus de révision, certaines grandes parties au niveau du contenu ont facilement trouvé leur place, ce qui met en évidence la robustesse de certains domaines de la littérature scientifique, comme l'épidémiologie, les analyses de comorbidité, les études de jumeaux, et certains autres plans d'études reposant sur la génétique. Les désaccords ont presque toujours tenu aux décisions sur la place des troubles pour lesquels les données soit manquent, soit (le plus souvent) sont contradictoires. Ainsi, par exemple, le trouble déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH) a été placé parmi les troubles neurodéveloppementaux sur la base du tableau symptomatologique, de la comorbidité et des facteurs de risque partagés. Mais les mêmes données suggéraient fortement que ce trouble pouvait tout aussi bien être placé parmi les troubles disruptifs, les troubles du contrôle moteur ou encore parmi les troubles des conduites. Ces difficultés ont été réglées en se référant au meilleur niveau de preuve scientifique (et en s'appuyant en particulier sur les validateurs approuvés par la *Task Force* du DSM-5). Les groupes de travail reconnaissent, cependant, que de futures découvertes pourraient très bien changer la place aussi bien que les contours des troubles individuels. Mieux, elles pourraient montrer que l'organisation simple et linéaire de la classification, qui est la plus adaptée à la pratique clinique, pourrait ne pas refléter entièrement la nature complexe et hétérogène de la pathologie mentale. La modification de l'organisation de la classification a été coordonnée avec le chapitre V de la CIM-11 consacré aux troubles mentaux et comportementaux, qui présentera un système de codage alphanumérique élargi. Il est cependant à noter que le système officiel de codage aux États-Unis, au moment où ce *Manuel* est publié, est désormais celui de la 9^e révision de l'adaptation américaine de la *Classification internationale des maladies* CIM-9), dénommée CIM-9-MC (pour « Modifications cliniques »). L'implantation de l'équivalent pour la CIM-10, la CIM-10-MC, est prévue aux États-Unis en octobre 2014. Plutôt que sur la CIM-10, il a néanmoins été jugé plus opportun de s'appuyer sur la CIM-11, dont la publication est imminente, pour travailler à l'harmonisation des systèmes classificatoires. Toutefois, vu que le système de codage de la CIM-9-MC sera encore en usage au moment où le DSM-5 paraîtra, il restera nécessaire d'utiliser les codes de la CIM-9-MC. Par ailleurs, la structure organisationnelle du DSM-5 anticipant celle de la CIM-11, les futurs codes de la CIM-11 suivront de manière plus proche l'ordre des diagnostics tels qu'il apparaît à travers les chapitres du DSM-5. On trouvera dans le présent manuel, en face de chaque trouble, les codes de la CIM-9-MC et ceux de la CIM-10-MC. Mais ces codes n'apparaissent pas dans un ordre séquentiel, n'étant que les reliquats des structures organisationnelles précédentes.

Approche diagnostique dimensionnelle

Différents problèmes structuraux sont apparus aussi bien dans la pratique clinique qu'en recherche. Ils tirent leur origine du plan d'organisation des éditions précédentes

du DSM, qui regroupent un grand nombre de catégories diagnostiques fines. Ces problèmes se manifestent dans la littérature scientifique sous différentes formes, notamment dans les études de comorbidité et dans le besoin très répandu de recourir aux catégories de troubles « non spécifiés » (catégories qui fournissent la majorité des diagnostics dans le domaine des troubles de l'alimentation, des troubles de la personnalité et du trouble du spectre de l'autisme). Les études génétiques ou les études portant sur les facteurs de risque environnementaux, qu'elles s'appuient sur les études de jumeaux, de transmission familiale ou d'analyses moléculaires, tendent également à mettre en cause la structure catégorielle du DSM. L'approche du DSM jusqu'à présent, dans la mesure où il considérait chaque diagnostic comme étant catégoriquement séparé des autres troubles ainsi que de l'état de santé, ne permettait pas de capturer le fait, pourtant démontré par les études de comorbidité, que de nombreux symptômes et facteurs de risque sont communs en psychiatrie. Les éditions précédentes du DSM s'étaient focalisées sur l'élimination des diagnostics faux positifs, au risque que les catégories deviennent beaucoup trop étroites (ce dont témoigne le recours très général aux catégories de troubles « non spécifiés » [NS]). En effet, le but, qui semblait alors plausible, d'identifier des populations homogènes pour le traitement et la recherche a conduit à la définition de catégories diagnostiques étroites qui ne capturent ni la réalité clinique ni l'hétérogénéité symptomatologique à l'intérieur des troubles mentaux, ni surtout le très important recoupement symptomatique retrouvé à travers de nombreux troubles mentaux. Cette aspiration historique à offrir une homogénéité diagnostique en proposant toujours davantage de sous-types à l'intérieur des catégories pathologiques n'est plus à l'ordre du jour ; comme la plupart des maux humains, les troubles mentaux sont hétérogènes à de nombreux niveaux, que ce soit au niveau symptomatique ou à celui des facteurs de risque génétiques.

En lien avec les recommandations qui ont été faites pour modifier la structure des chapitres du DSM-5, les membres du groupe chargé de l'étude des spectres diagnostiques ont examiné si des validateurs scientifiques étaient susceptibles de justifier de nouveaux regroupements possibles de troubles associés au sein de la structure catégorielle existante. Onze de ces indicateurs ont été définis pour remplir ce but : le fait de partager des substrats neuronaux, les traits familiaux, les facteurs de risque génétiques, les facteurs spécifiques de risque environnemental, les biomarqueurs, les antécédents au niveau du tempérament, la présence d'anomalies dans le fonctionnement émotionnel ou cognitif, la similarité symptomatique, l'évolution de la maladie, le haut degré de comorbidité, et enfin les similitudes dans la réponse au traitement. Ces indicateurs ont été utilisés par les membres de la *Task Force* et des groupes de travail comme autant de règles empiriques pour aider à la prise de décision quant à la meilleure manière de regrouper les troubles, tout en maximisant leur validité et leur utilité cliniques.

Un ensemble d'articles conjoints aux processus développementaux du DSM-5 et de la CIM-11 a été élaboré et publié dans un journal international très renommé (*Psychological Medicine*, 2009 ; 39). Ils ont mis en évidence que tous ces validateurs tendaient davantage à justifier des regroupements larges de troubles qu'à « valider » les critères diagnostiques des troubles individuels. Le regroupement des troubles mentaux retenu pour le DSM-5 a pour but de favoriser les recherches futures, en vue d'améliorer la compréhension de l'origine et des points communs qui existent entre les troubles. Il vise également à fournir une base pour les futures études de réplification (en permettant une réanalyse dans le temps des données et des mesures continues de la validité). Les révisions continues qui sont prévues feront du DSM-5 un « document vivant », adaptable aux futures découvertes en neurobiologie, en génétique et en épidémiologie.

Les résultats publiés de cette analyse commune au DSM-5 et à la CIM-11 ont démontré que le regroupement des troubles en fonction de ce qui a été dénommé les facteurs d'*internalisation* ou d'*externalisation* constituait une option empiriquement solide. Autant à l'intérieur du groupe internalisé (représentant les troubles où prédominent les symptômes anxieux, dépressifs et somatiques) et du groupe externalisé (représentant les troubles où prédominent les symptômes impulsifs, de conduite disruptive et de dépendance à l'usage d'une substance), les études de jumeaux ont mis en évidence l'existence de facteurs de risque génétiques et environnementaux communs susceptibles d'expliquer une grande partie des phénomènes généraux de comorbidité observés dans les échantillons cliniques et en population générale.

Le regroupement des « troubles internalisés », caractérisés par une humeur dépressive, de l'anxiété et certains symptômes cognitifs ou physiologiques, devrait favoriser le développement de nouvelles approches diagnostiques (et notamment des approches dimensionnelles) tout en facilitant l'identification de marqueurs biologiques. De la même manière, la proximité du « groupe externalisé », qui comprend les troubles présentant des comportements antisociaux, des troubles de la conduite, des dépendances, des troubles du contrôle des impulsions, devrait favoriser les progrès dans l'identification des diagnostics, des marqueurs et des mécanismes sous-jacents.

Malgré toutes les difficultés posées par les diagnostics catégoriels, les membres de la *Task Force* du DSM-5 ont convenu qu'il était scientifiquement prématuré de proposer des définitions alternatives pour la plupart des troubles pathologiques. La nouvelle structure organisationnelle vise à jeter un pont en direction des nouvelles approches diagnostiques, tout en maintenant la continuité avec les pratiques cliniques et la recherche actuelles. Grâce aux matériels d'entraînement associés au DSM, aux autres agences de financement des *National Institutes of Health*, et aux publications scientifiques, l'approche plus dimensionnelle du DSM-5 et sa structure organisationnelle vont faciliter les recherches transversales aux catégories diagnostiques actuelles, en encourageant les études étendues aussi bien à l'intérieur des chapitres proposés qu'en tenant compte des chapitres adjacents. Une telle redéfinition des buts de recherche devrait également permettre au DSM-5 de rester central dans le développement des approches dimensionnelles du diagnostic, qui seront probablement amenées, dans les années à venir, à compléter voire à remplacer les approches catégorielles actuelles.

Considérations liées au développement et au cours de la vie

Afin d'améliorer l'utilité clinique, le DSM-5 est organisé en fonction des aspects développementaux et du cours de la vie. Il commence en présentant les diagnostics qui sont considérés comme reflétant des processus développementaux se manifestant tôt dans la vie (p. ex. le spectre neurodéveloppemental et le spectre de la schizophrénie, ainsi que les autres troubles psychotiques). Il se poursuit avec les diagnostics qui se manifestent plus souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte (p. ex. les troubles bipolaires, dépressifs ou anxieux). Il se termine avec les diagnostics qui se posent à l'âge adulte ou tardivement dans la vie (p. ex. les troubles neurocognitifs). Chaque fois que cela a été possible, la même approche a été reproduite dans chaque chapitre. Cette structure organisationnelle facilite la décision diagnostique en tenant compte de tous les renseignements liés à l'âge.

L'organisation qui est proposée du DSM-5 en chapitres, après les troubles neurodéveloppementaux, s'appuie sur une division entre le groupe des troubles internalisés (émotionnels et somatiques), les troubles externalisés, les troubles neurocognitifs et les autres troubles. Nous espérons que cette organisation encouragera les études à venir concernant les processus physiopathologiques qui sont à l'origine des phénomènes de

comorbidité diagnostique et d'hétérogénéité symptomatique. Qui plus est, par le classement des troubles en groupes destinés à mieux refléter la réalité clinique, le DSM-5 devrait faciliter l'identification des diagnostics par les médecins qui ne sont pas spécialistes en médecine mentale, et notamment les médecins généralistes.

La structure organisationnelle du DSM-5, de pair avec l'harmonisation avec la CIM, a pour but de fournir des concepts diagnostiques qui soient à la fois meilleurs et plus flexibles pour une nouvelle ère de la recherche. Elle a aussi pour but de servir de guide pratique aux cliniciens en leur permettant d'expliquer aux patients pourquoi ils reçoivent plusieurs diagnostics ou parfois des diagnostics supplémentaires ou différents au cours de leur vie.

Questions culturelles

Les troubles mentaux sont définis en tenant compte des normes et des valeurs culturelles, sociales et familiales. La culture fournit aux individus des cadres interprétatifs qui façonnent l'expérience et l'expression des symptômes, des signes et des comportements qui fournissent la matière des critères diagnostiques. La culture est transmise, révisée et recrée à l'intérieur de la famille et des autres institutions ou systèmes sociaux. L'évaluation diagnostique, en conséquence, doit rechercher si les expériences d'un individu, les symptômes ou les comportements qu'il présente, diffèrent des normes socioculturelles et si cela conduit à des difficultés dans l'adaptation à la culture dont il est issu ou dans des contextes sociaux ou familiaux spécifiques. Les aspects culturels les plus centraux qui touchent à la classification et à l'évaluation diagnostiques ont été pris en compte au cours du développement du DSM-5.

Dans la section III, intitulée « Formulations culturelles », on trouvera une discussion détaillée des rapports entre culture et diagnostic dans le DSM-5, ainsi que des instruments permettant une évaluation culturelle approfondie. Dans l'annexe, le « Glossaire des concepts culturels de détresse » fournit la description de certains syndromes culturels répandus, certains idiomes de détresse et certaines explications causales qui peuvent éclairer la pratique clinique.

Les frontières entre le normal et le pathologique, pour certains types de comportements particuliers, varient suivant les cultures. Les seuils de tolérance concernant certains symptômes ou comportements spécifiques diffèrent également suivant les cultures, les cadres sociaux ou familiaux. Tout cela explique que le niveau à partir duquel une expérience peut devenir problématique ou pathologique variera aussi. Le jugement suivant lequel tel comportement est anormal et requiert une attention clinique dépend de normes culturelles intériorisées par l'individu et véhiculées par les autres autour de lui, comme les membres de sa famille ou les cliniciens. La prise de conscience de l'importance que représente la culture peut permettre de corriger certaines interprétations fausses en psychopathologie mais la culture elle-même peut contribuer à augmenter la vulnérabilité ou la souffrance (p. ex. en amplifiant les peurs qui déclenchent les attaques de panique ou un rapport anxieux à la santé). Les significations culturelles, les habitudes et les traditions peuvent également contribuer tantôt à la stigmatisation, tantôt à un meilleur soutien familial et social face à la maladie mentale. La culture peut aussi fournir des stratégies pour faire face qui améliorent la résilience, qui peuvent stimuler la demande d'aide ou suggérer différentes options d'accès au soin, comme les systèmes de santé complémentaires ou les médecines alternatives. La culture joue un rôle dans le fait d'accepter ou de rejeter un diagnostic, dans l'adhésion au traitement, et tout cela n'est pas sans affecter l'évolution de la maladie ou

les possibilités de rétablissement. La culture influence également le déroulement de la consultation clinique, au point que des différences culturelles qui existent entre le clinicien et le patient peuvent avoir des implications sur la précision ou l'acceptation du diagnostic, sur les décisions relatives au traitement, les considérations pronostiques ou encore les résultats cliniques.

Historiquement, l'un des intérêts centraux de la psychiatrie culturelle a reposé sur la détermination de syndromes propres à une culture donnée. Dans le DSM-5, ce schéma a été remplacé par l'introduction de trois concepts présentant une plus grande utilité clinique :

1. *Un syndrome culturel* est un ensemble ou un groupe de symptômes concomitants et relativement invariants dans un groupe culturel, une communauté ou un contexte donnés (p. ex. *ataque de nervios*). Ce syndrome peut être reconnu ou non comme pathologique au sein d'une culture (p. ex. il peut être dénommé de différentes manières) mais de tels tableaux culturels de souffrance et de telles caractéristiques pathologiques peuvent néanmoins être identifiés par un observateur extérieur.
2. *Un idiome culturel de détresse* désigne un terme linguistique, une expression ou une manière de parler d'une souffrance qui est commune aux individus d'un groupe culturel donné (p. ex. appartenant au même groupe ethnique ou religieux) et qui renvoie à des concepts partagés concernant le pathologique, des manières d'exprimer, de communiquer, de dénommer certaines caractéristiques essentielles d'une détresse (p. ex. *kufungisisa*). Les idiomes de détresse ne sont pas nécessairement associés à des symptômes, des syndromes ou des causes perçues particulières. Ils peuvent être mobilisés pour exprimer une grande variété d'expériences inconfortables, des expériences de la vie ordinaire jusqu'aux conditions infracliniques, en passant par la souffrance, liées aux circonstances sociales plutôt qu'aux maladies mentales. Par exemple, on trouve dans la plupart des cultures des idiomes de détresse corporels qui servent à exprimer une grande variété de souffrances ou de problèmes.
3. *Une explication culturelle ou une cause perçue* désigne une étiquette, une attribution ou une caractéristique d'un modèle explicatif qui fournit une manière culturelle de concevoir l'étiologie ou la cause des symptômes, des maladies ou de la détresse (p. ex. *maladi moun*). Les explications causales peuvent constituer des caractéristiques importantes des classifications vernaculaires des maladies utilisées par le public profane ou les guérisseurs.
4. Ces trois concepts (dont on trouvera les analyses et des exemples dans la section III ainsi que dans l'annexe) expriment les différentes façons culturelles dont la compréhension et la description des expériences de la maladie peuvent être évoquées lors de la rencontre clinique. Ils influencent la symptomatologie, la demande de soin, les présentations cliniques, les attentes quant au traitement, l'adaptation à la maladie, ainsi que la réponse au traitement. Un même terme culturel remplit souvent plusieurs de ces fonctions.

Différences de genre

Les différences selon le sexe et le genre dans la mesure où elles concernent les causes et les expressions des affections médicales, sont considérées pour un certain nombre de maladies, dont certains troubles mentaux particuliers. L'examen des différences possibles qui existent entre les hommes et les femmes dans l'expression de la maladie mentale faisait partie du processus de révision pour le DSM-5. Sur le plan du vocabulaire,